

MEDQUERY AI - DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE CLÍNICO

ID Documento: MQ-SCO-303

Título: Clasificación de Neumonía Adquirida en la Comunidad (CURB-65)

Diagnóstico Presuntivo: Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC)

Síntomas Guía: Tos, fiebre, disnea, esputo purulento, alteración del sensorio

Especialidad: SPEC_{EMERG}

Versión: v1.1 (Septiembre 2026)

Población Objetivo: Adulto

Medical Owner: Jefatura de Clínica

BLOQUE DE ACCIÓN OPERATIVA - TRIAGE: URG_L2_ORANGE

Acción de Primera Línea: Calcular el score CURB-65 de forma obligatoria en todo paciente con sospecha clínica o radiológica de NAC dentro de los primeros 30 minutos de su ingreso a la guardia. Monitorizar de inmediato la saturación de oxígeno (O_2).

Drogas de Elección (Según Estratificación):

- **Moderado** (*Puntaje = 2*): Amoxicilina/Ácido Clavulánico 1 g/200 mg IV cada 8 horas o Ceftriaxona 1 a 2 g IV cada 24 horas, asociado a Claritromicina 500 mg IV cada 12 horas.
- **Severo** (*Puntaje ≥ 3*): Ceftriaxona 2 g IV cada 24 horas + Claritromicina 500 mg IV cada 12 horas. Evaluar necesidad de soporte ventilatorio.

Alerta de Seguridad / Contraindicación Crítica: Se prohíbe el alta médica ambulatoria si el paciente presenta un puntaje CURB-65 ≥ 2 o una saturación de oxígeno inferior al 92 % al aire ambiente. La primera dosis de antibiótico empírico debe administrarse en la guardia y no puede demorarse más de 4 horas desde el ingreso del paciente.

1 Introducción y Objetivos

La Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) presenta una morbilidad significativa si no se la estatifica a tiempo. Este protocolo provee una herramienta objetiva basada en la evidencia para guiar al médico de guardia en la toma de decisiones críticas: definir si el paciente es apto para tratamiento ambulatorio, si requiere internación en sala general o si debe ser derivado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (SPEC_ICU).

2 Estructura del Score CURB-65

El sistema asigna un (1) punto por cada uno de los siguientes criterios clínicos y laboratoriales presentes al ingreso:

- **Confusión:** Alteración aguda del nivel de conciencia o desorientación en tiempo, espacio o persona.
- **Urea:** Concentración de urea en sangre superior a 7 mmol/L (o nitrógeno ureico en sangre - BUN > 19 mg/dL).
- **Respiración:** Frecuencia respiratoria igual o mayor a 30 respiraciones por minuto.
- **Blood Pressure (Presión Arterial):** Presión arterial sistólica < 90 mmHg o presión arterial diastólica ≤ 60 mmHg.
- **65:** Edad del paciente igual o mayor a 65 años.

3 Algoritmo de Derivación e Internación Interna

La conducta clínica institucional se define estrictamente según el puntaje consolidado:

1. **Grupo 1 (0 a 1 punto) - Riesgo Bajo:** Mortalidad menor al 1.5 %. El manejo recomendado es ambulatorio con tratamiento oral (Amoxicilina 1 g cada 8 horas VO) y pautas de alarma estrictas, salvo que existan condicionantes sociales o comorbilidades descompensadas.

2. **Grupo 2 (2 puntos) - Riesgo Moderado:** Mortalidad aproximada del 9.2%. Requiere internación en la sala de Clínica Médica para supervisión clínica, soporte hidroelectrolítico y antibioticoterapia combinada por vía intravenosa.
3. **Grupo 3 (≥ 3 puntos) - Riesgo Severo:** Mortalidad superior al 22%. Requiere internación mandatoria. Si el puntaje es de 4 o 5, se debe realizar la interconsulta inmediata con el médico intensivista para evaluar el ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (SPEC_ICU).

4 Criterios de Ingreso Directo a UCI (ATS/IDSA)

Independientemente del CURB-65, un paciente con NAC debe ingresar a la UTI si cumple con al menos un (1) criterio mayor o tres (3) criterios menores:

- **Criterios Mayores:** Necesidad de ventilación mecánica asistida o choque séptico que requiera el uso de drogas vasopresoras (Noradrenalina).
- **Criterios Menores:** Frecuencia respiratoria ≥ 30 rpm, relación $PaO_2/FiO_2 \leq 250$, infiltrados multilobares en radiografía de tórax, confusión, uremia (BUN > 20 mg/dL), leucopenia, trombocitopenia o hipotermia.